



a.



b.

図1 AEPの画像所見

a: 胸部X線写真

b: 胸部CT（末梢優位のすりガラス陰影と胸水貯留）

表1 急性好酸球性肺炎（AEP）の診断基準（Allen）

1. 7日以内の急性経過
2. 室内気で $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$ の低 O_2 血症
3. 両側のびまん性浸潤陰影
4. 肺組織への著明な好酸球浸潤（BALF中の好酸球比率 $> 25\%$ ）
5. 寄生虫や真菌を含む感染症がない，気管支喘息や他のアレルギー疾患の既往がない
6. ステロイド薬に対する反応が良好である
7. 治療終了後に再発がない

[Allen JN, et al: N Engl J Med 321: 569, 1989 より引用]

他疾患を鑑別して確定診断を行う。定まった診断基準はないが，従来はAllenの診断基準（表1）が用いられていたが¹⁾，1週間以上経過して発症する症例や自然軽快する症例も認められることから最近ではPhilitらの診断基準（表2）が用いられることが多い^{5,6)}。

鑑別すべき疾患は，急性発症で発熱，咳嗽，呼吸困難の症状とびまん性陰影を呈する非定型肺炎（マイコプラズマ肺炎，クラミジア肺炎，レジオネラ肺炎，ウイルス性肺炎，ニューモシスチス肺炎など），過敏性肺炎，薬剤性肺炎，急性呼吸窮迫症候群（ARDS），急性間質性肺炎（acute interstitial pneumonia: AIP）などがある。

治療と予後

無治療で自然軽快する例も報告されているが，90%以上の症例でステロイド治療が行われている。一般に副腎皮質ステロイド薬に対する反応性は良好である。初期投与量は呼吸不全の程度に応じてprednisolone 0.5~1.0 mg/kg/dayを使用し，重症例ではパルス療

表2 急性好酸球性肺炎（AEP）の診断基準（Philit）

1. 発熱性の呼吸器症状を1ヵ月以内の急性発症
2. 両側の浸潤影が胸部X線でみられる
3. BALにおいて $> 25\%$ の好酸球が確認できる，あるいは肺生検において好酸球性肺炎が証明される
4. 薬剤，毒物，感染などの肺好酸球症の原因がはっきりしないもの

[Philit F, et al: Am J Respir Crit Care Med 166: 1235-1239, 2002 および Cottin V, et al: Allergy 60: 841-857, 2005 より引用]

法を考慮する。副腎皮質ステロイド薬は臨床経過をみながら早期に漸減を行い，通常2~4週以内で治癒するが，最近の報告では，呼吸不全が存在する場合でも治療期間は2週間でよいと報告されている⁷⁾。一般に，予後は良好で再発はないが，喫煙が原因の場合は，タバコ煙に対する寛容が誘導されることに起因すると考えられている⁸⁾。

2

慢性好酸球性肺炎

chronic eosinophilic pneumonia (CEP)

到達目標

- ◆ 慢性好酸球性肺炎と急性好酸球性肺炎の共通点と相違点を以下の点について概説できる
- ◆ 病態，疫学，画像所見，検査所見，治療法，慢性好酸球性肺炎の鑑別診断を説明できる
- ◆ 両疾患の予後の違いを理解できる